

RÔLE DU FOIE

MÉTABOLISME = Glucides, lipides (cholestérol, protéines (albumine, vit D).
ÉPURATION = Destruction hématies usées, neutralisation toxines & hormones, conversion de l'ammoniac
STOCKAGE = Vitamines A,D, E,K glycogène, Fer, Cu, B12
DIGESTION = Emulsion des graisses (production de bile)

RÔLE DE LA VÉSICULE BILIAIRE

Emmagasine et concentre la bile. La bile permet la digestion des lipides.
Bile = Eau + bicarbonates + sels biliaires + lécithine + pigments biliaires

INSUFFISANCE HÉPATIQUE

1 DÉFINITION

Ensemble des manifestations cliniques et biologiques dues à une diminution de la masse des cellules hépatiques.

Stade	Manifestations
Modéré	Fatigue, amaigrissement, hypersensibilité aux médicaments
Avancé	Ictère, troubles de l'hémostase, somnolence, troubles nerveux, endocriniens

2 DIAGNOSTIC – analyses sanguines

- ✓ Transaminases (ASAT, ALAT)
- ✓ Gamma-GT
- ✓ Phosphatases alcalines (PAL)
- ✓ Bilirubine

Ces marqueurs augmentent lors de la destruction des cellules hépatiques.

3 CAUSES / INSUFFISSANCE HÉPATIQUE

- ✓ Hépatite virale / toxique / Hépatite médicamenteuse
- ✓ Cirrhose / Tumeur hépatique

4 TRAITEMENT

 **Objectif allopathique** Traiter la cause (hépatite, cirrhose...)

 **En naturopathie**

✗ **Aucun accompagnement possible**

Le foie ne peut pas être remplacé = Seule la greffe peut sauver

SURCHARGE HÉPATIQUE

1 DÉFINITION

Difficulté du foie à éliminer les déchets colloïdaux , surcharge de féculents / graisses saturées , trop de médicaments , stress chronique
→ sans destruction cellulaire
→ non reconnue comme maladie par l'allopathie

Symptômes :

Acné, Migraine, Selles grasses et flottantes
Halitose (Langue blanche, bouche pâteuse) Digestion lentes (graisses difficile)

2 CAUSES

Facteur	Mécanisme
Alimentation inadaptée	Excès de féculents et graisses saturées
Terrain	Mauvaise élimination
Stress chronique	Freine la détox
Polymédication	Saturation enzymatique

3 QUESTIONS À POSER

Selles grasses ? Migraines ? Langue blanche, haleine ? Peau grasse, acné ?

4 ALLOPATHIE

Pas de traitement = La surcharge n'est pas reconnue comme pathologie

5 STRATÉGIE NATUROPATHIQUE

Objectif

Stimuler la fonction hépatobiliaire pour éliminer les toxines

A. Alimentation hépatoprotectrice

Légumes verts , Crucifères , Navet , Romarin , Citron , Curcuma, Radis noir, Artichaut

B. Drainage thermique

Bouillotte chaude sur le foie après les repas
Bain chaud

C. Gestion du stress

Relaxation / Respiration

D. Phytothérapie

Attention plantes inductrices éliminent plus vite le médicament donc moins efficace.

Plantes Inhibitrices ralentissement de l'élimination du médicament = risque toxicité

(plantes cholérétiques & cholagogues)

Chardon-Marie, Ex peut inhiber le traitement par ibuprofene donc peut etre plus toxiques. (voir tableau)

Plantes =Artichaut /Fumeterre / Boldo /Radis noir

	CYP1A2	CYP2C9*	CYP2D6*	CYP3A4
SUBSTRAT	théophylline caféine	Phénytoïne Diclofenac Warfarine	codéine captopril imipramine fluoxétine metoprolol	ciclosporine tacrolimus ketoconazole midazolam statine
INHIBITEUR	cimétidine quinolones fluvoxamine SFN CHARDON MARIE	Isoniazide ritonavir CURCUMA	quinidine fluoxétine CHARDON MARIE CURCUMA	macrolides naringénine (jus pamplemousse) Antifongiques azolés Antiprotéases CHARDON MARIE SFN CURCUMA
INDUCTEUR	rifampicine omeprazole cigarette RÉGUSSE	rifampicine	 FUMETERRE	carbamazépine phénytoïne phenobarbital Millepertuis (tisanes...) MILLEPERTUIS

D'après LPEV

Avant de préconiser la plante, il faut connaître la voie métabolique d'élimination du médicament, soit l'isoenzyme du cytochrome P450 qui est active pour ce médicament.

Ensuite, il faut regarder les plantes inhibitrices ou inductrices de l'isoenzyme et ne pas les préconiser car risque que le médicament ne soit plus efficace ou risque qu'il devienne toxique ou dangereux.

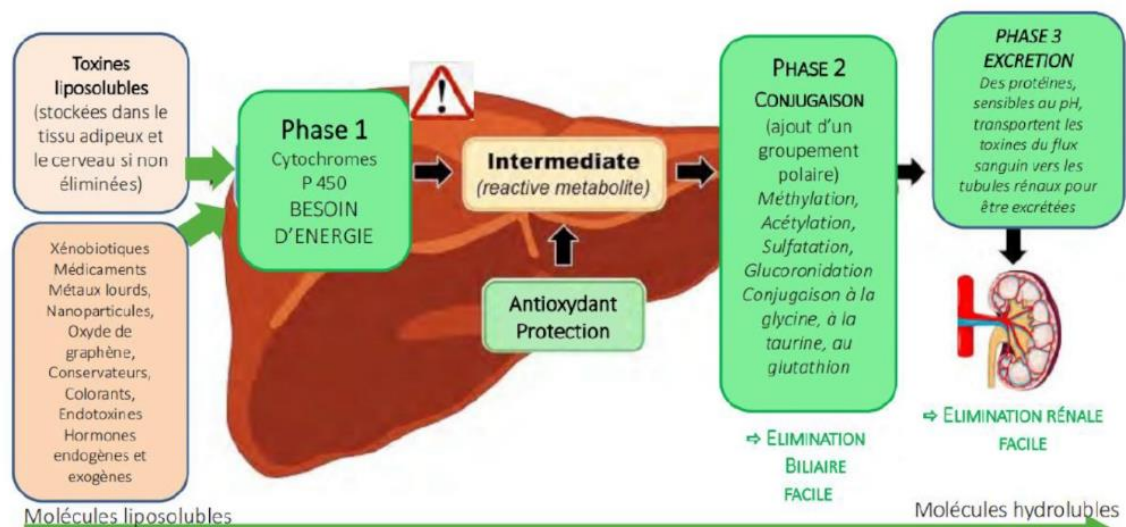
Ex : Alprazolam (CY3A4/5) + Millepertuis (inducteur puissant du CY3A4/5) → Diminution l'efficacité de l'Alprazolam.



E. Aromathérapie (post-médication lourde)

Livèche /Carotte / Romarin à verbénone /Lédon du Groenland /Citron

RAPPELS DETOXIFICATION DU HÉPATIQUE



PHASE 1 =Transformer la toxine en un métabolite réactif

Les CYP450 sont une famille d'enzymes hépatiques.

Ils font : oxydation / Réduction / hydrolyse

Ils utilisent : oxygène / NADPH / vitamines B /minéraux (Fe, Mg)

Ils transforment une toxine liposoluble en un :métabolite intermédiaire réactif (souvent plus toxique que la molécule initiale) ⚠ C'est la phase la plus dangereuse.

PHASE 2 = Rendre la toxique hydrosoluble Le foie colle un « manche hydrophile » au métabolite toxique. Les voies : Glutathion,Glycine , Taurine , Sulfates, Méthylation , Glucuronidation 🐾 C'est la vraie phase de protection.

PHASE 3 = Les toxines conjuguées sont éliminées par :

la bile → selles / les reins → urines

Cela dépend : de la bile /du transit / du microbiote / des reins

⚠ LE DANGER MAJEUR

Si :Phase 1 trop rapide OU Phase 2 trop lente

Alors tu accumules :des métabolites toxiques hautement inflammatoires

C'est exactement le terrain :fatigue chronique ,hypersensibilité chimique

troubles neuro ,inflammation de bas grade ,TDAH, anxiété, brouillard mental

• Données biologiques

Cholestase :

Réduction ou arrêt du flux biliaire



Cytolyse hépatique :

Destruction des cellules

Paramètres	Cholestase	Cytolyse
Albumine	N	N
Bilirubine	N ou augmenté	N ou augmenté
Cholestérol	Augmenté	N
Fer	N	Augmenté
Gamma GT	Augmenté	N ou augmenté
LDH	N	Augmenté
Phosphatases alcalines	N ou augmenté	N ou augmenté
Transaminases	N ou augmenté	Augmenté +++
TP	Bas avec un facteur V normal	N
Vit A, D, E, K	Bas	N

Ce tableau sert à distinguer deux grands types d'atteinte du foie grâce à la prise de sang :

● Cholestase

➡ Problème de circulation de la bile
La bile est produite par le foie et doit s'évacuer vers l'intestin.

Si elle stagne → elle reflue dans le sang → certains marqueurs montent.

- ✓ Causes typiques :
- ✓ calculs biliaires
- ✓ inflammation des voies biliaires
- ✓ médicaments
- ✓ foie engorgé, surcharge hépatique

● Cytolyse hépatique

➡ Les cellules du foie sont détruites
Elles libèrent leurs enzymes dans le sang.

Causes typiques :
hépatites (virales, toxiques, alcool, médicaments)
stéatose (foie gras)
surcharge métabolique, inflammation chronique

2 Comment lire le tableau

Paramètre	Si c'est une cholestase	Si c'est une cytolysse
Gamma-GT	▲ Augmenté	Normal ou ▲
Phosphatases alcalines (PAL)	▲ souvent	▲ parfois

Transaminases (ASAT, ALAT)	N ou légèrement ▲	▲ ▲ ▲ très élevées
Bilirubine	N (NORMAL)ou ▲ (jaunisse possible)	N ou ▲
Cholestérol	▲	Normal
Fer	Normal	▲
LDH	Normal	▲
Vit A, D, E, K	▼ (mauvaise absorption)	Normal
TP (coagulation)	Peut baisser	Normal

3 La clé pour comprendre rapidement

● Cholestase = problème de tuyauterie = Les canalisations sont bouchées → la bile déborde

La bile ne sort pas

→ Gamma-GT + PAL + cholestérol + vitamines liposolubles anormales

● Cytolyse = problème de cellules

Les cellules éclatent = Les machines explosent → enzymes dans le sang

→ Transaminases très élevées + LDH + fer

5 Pourquoi c'est fondamental en naturopathie

Parce que la stratégie n'est pas la même :

Si cholestase	Si cytolyse
Draine la bile	Protège et régénère le foie
Fluidifier	Anti-inflammatoire
Plantes cholérétiques	Antioxydants
Artichaut, chardon-marie, radis noir	Curcuma, NAC, glutathion, silymarine